

SALUD Y DIVERSIDAD SEXUAL
EXPERIENCIAS DE MUJERES LESBIANAS Y BISEXUALES CISGÉNERO EN
BOGOTÁ D.C

Por:

GABRIELA VILLAMIZAR DIEZ
Estudiante de Maestría en Género

PhD JAVIER ARMANDO PINEDA DUQUE
Director de Trabajo de Grado

Tesis
Para optar por el título de Maestría en Género

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

enero 2024

Agradecimientos.

*A mi mamá, María Cristina Díez Trujillo,
Gracias por ser una fuente inagotable de determinación.
Este triunfo y los que seguirán están dedicados a ti.
Adonde vayas, iré; donde te quedes, me quedaré ¡Lo mejor está por venir, Ma!*

*A mi papá y mis hermanos, Jorge E. Villamizar Navarro, Nicolas y Diego,
les agradezco siempre su apoyo incondicional. Lamento el impacto de las jerarquías del
género y anhelo con fervor un futuro sin géneros que nos distancien,
La Equidad No Puede Existir Mientras Persistan Esta Jerarquía, El Género;*

En esta vida, cultivemos valentía, empatía y gentileza para tratar a cada ser humano.

*Al CIDER, a Esmith, Ana Yudi, Lisbeth, Verónica, a la profesora Diana y al profesor Javier,
quien representa el tesoro más valioso de mi experiencia en la facultad, les extiendo mi
infinita gratitud.*

*Un profundo reconocimiento a la ginecóloga guajira Dauris Mejía Perez.
Gracias de corazón por la asesoría y el cuidado.*

*A las mujeres lesbianas y bisexuales que participaron en este estudio, gracias.
A quienes luchamos por aceptar nuestra orientación sexual e identidad, ánimo y suerte.*

*“La vida es un ratico”
María Claudia Arango Ochoa*

SALUD Y DIVERSIDAD SEXUAL EXPERIENCIAS DE MUJERES LESBIANAS Y BISEXUALES CISGÉNERO EN BOGOTÁ D.C.

Resumen

Ser una mujer lesbiana o bisexual requiere de unos cuidados sexuales específicos, por ejemplo, los métodos de barrera para sexo entre mujeres incluyen la barrera de látex para la vagina, para los dedos tipo dedal, también conocidos como condones para los dedos. Este artículo identifica sesgos de género en el sistema y los operadores de salud a partir de las experiencias de mujeres cisgénero lesbianas y bisexuales en los servicios de salud de Bogotá DC. Con base a 14 entrevistas semiestructuradas, once a mujeres jóvenes entre 20 y 30 años y tres profesionales de la salud, se concluye que la heteronormatividad está presente en el sistema de salud, limitando la calidad en salud sexual de estas mujeres.

Palabras clave: diversidad sexual, salud sexual, lesbianas, heteronormatividad.

Abstract

Being a lesbian or bisexual woman requires specific sexual care, for example, barrier methods for sex between women include the latex vaginal barrier or thimble-type finger condoms. This article identifies gender biases in the health system and health operators based on the experiences of lesbian and bisexual cisgender women in health services in Bogotá DC. Based on 14 semi-structured interviews, eleven young women between 20 and 30 years of age and three health professionals, it is concluded that heteronormativity is present in the health system, limiting the quality of sexual health of these women.

Key words: sexual diversity, sexual health, lesbians, heteronormativity.

Introducción

La salud sexual es considerada por la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar físico, mental y social en la dimensión sexual (OMS, 2017). Por lo tanto, busca que todas las personas, independiente de su orientación sexual, tengan una vida sexual plena, placentera y libre de discriminación. Sin embargo, existen factores dentro de cada país que afectan la salud sexual de sus ciudadanos/as, entre ellos, la cultura y la educación, las políticas públicas, el marco legislativo y el acceso al sistema de salud (WHO, 2010).

Particularmente, se han reconocido diversas problemáticas que afectan la salud de las mujeres lesbianas y bisexuales (MLB), la falta de información adecuada y los estigmas sociales crean barreras de acceso a la atención médica inclusiva (Sobecki, Brown, & Gaupp, 2017). Existe una invisibilidad y discriminación hacia MLB la cual puede producir estrés y ansiedad en las pacientes. Además, la falta de educación sexual específica para MLB puede llevar a la ignorancia sobre prácticas seguras y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. En el contexto colombiano existe un conocimiento limitado en este sentido (Palma, 2019).

Si bien en Colombia el acceso a la salud es un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución Política, este no se garantiza de manera igualitaria para todas las personas (Hilarión et al., 2019). Caso puntual resulta ser el de las personas disidentes de la cisheteronormatividad — aquellas que no se ajustan a las expectativas tradicionales de género y orientación sexual que predominan en la sociedad, las cuales suelen estar basadas en la cissexualidad (identidad de género que coincide con el sexo asignado al nacer) y la heterosexualidad (atracción romántica y sexual hacia personas del sexo opuesto) —, quienes enfrentan una serie de barreras que dificultan su acceso a la atención médica (Temblor, 2021).

Por su parte, Chaparro (2015) y Formby (2011) precisan que la homofobia y el heterosexismo son factores presentes en la atención en salud de las MLB, haciendo que no siempre tengan un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. En Colombia, se evidencia una notable disparidad en el acceso a los servicios de salud para las MLB, lo que se traduce en una disminución significativa de su acceso a la atención médica. Como señala Palma y Orcasita (2019), esta desigualdad se origina en gran medida en el hecho de que muchas MLB experimentan una profunda incomodidad al momento de revelar su orientación sexual en contextos de atención médica, lo que, lamentablemente, conduce en numerosas ocasiones a la carencia de una atención apropiada. Adicionalmente, el estudio realizado por Hiestand, Horne

& Levitt (2007), destaca que las MLB con frecuencia enfrentan dificultades considerables al tratar de localizar profesionales de la salud que demuestren comprensión y respeto hacia su diversidad sexual, agravando aún más los retos que enfrentan en su búsqueda de atención médica inclusiva y de alta calidad.

La población de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI+) hace referencia a una amplia categoría de personas con una orientación sexual o una identidad de género diversa (Barrera, 2017). Según una encuesta reciente (Brigeiro, Castillo, y Murad, 2009), que incluyó a 1275 personas LGBTI+, se reveló que las MLB presentaron las tasas más elevadas de no afiliación a ningún régimen de salud, lo que implica la falta de cobertura médica en el país. En concordancia, un ejemplo del acceso limitado a servicios es que las MLB muestran menores índices de realización de pruebas como la citología y la mamografía (Mollon, 2012). Solo 20 % aseguró haber usado métodos de autocuidado como el condón o barreras de látex y el 40 % ha recibido atención en salud sexual (Brigeiro et al., 2009).

Dentro de la literatura académica se identifica una brecha de conocimiento frente a esta problemática, la situación en salud de las MLB en Bogotá, capital colombiana, es precaria y poco conocida. Existen estudios que hablan de la situación en otras ciudades del país, como Cali (Palma, 2019), (Arias et al, 2011). Incluso existen estudios que hablan sobre la situación de las mujeres migrantes LGBTI+ en Cali (Ortiz et al, 2023). Sin embargo, los estudios académicos que hablan de las MLB en Bogotá (Ruiz-Sternberg et al, 2010) son estudios donde se habla de la salud sexual y reproductiva de la comunidad en general, haciendo un enfoque en estudiantes. Por consiguiente, la presente tesis identifica una brecha dentro del conocimiento académico frente a la situación de salud sexual de las MLB en Bogotá y propone un estudio cualitativo para cerrar dicha brecha.

El sistema de salud en Colombia está compuesto por dos sectores, el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y el privado. El primero tiene a su vez dos regímenes, el régimen contributivo (RC) y el régimen subsidiado (RS). El RC afilia a trabajadores asalariados e independientes. El RS afilia a las personas que se encuentran en la informalidad y/o no tienen capacidad de pago (Guerrero *et al.*, 2011, p. 145). Gracias a la Ley 1438 de 2011, se realizó una reforma al SGSSS y se estableció el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012 – 2021, el cual aborda a la salud desde cuatro enfoques: salud como derecho, determinantes sociales de la salud, enfoque diferencial y enfoque poblacional (Carmona y Parra-Padilla, 2015, p. 615).

El enfoque diferencial busca reconocer la diversidad de la población y cómo existen características específicas en personas y comunidades que influyen en su salud y bienestar (Teresi, 2006). Estas características pueden ser dadas por distintas categorías de diferenciación social como: raza, género, orientación sexual, edad, localización geográfica, estrato social o condición de discapacidad. En consecuencia, “es dinámico y flexible para adaptarse a las necesidades y características de la población, su autorreconocimiento, sus modos de vida y sus contextos socioculturales, económicos y políticos” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2023). El sistema de salud colombiano busca entonces una equidad en la forma de atender a las poblaciones y busca brindar una atención integral, la cual es reflejo de esfuerzos de políticas internacionales y nacionales las cuales reconfiguran el sistema. Sin embargo, existe un largo camino por recorrer, pues en Colombia persisten desigualdades en salud frente al acceso y a la afiliación, las brechas en las condiciones sociales y económicas de la población se mantienen y esto genera inequidades en salud (Hilarión et al., 2019, p. 738). En las MLB, específicamente, se encuentra el bajo uso de preservativos, el hallazgo de infecciones de transmisión sexual y la ausencia de consultas por ginecología (Navarro *et al.*, 2016).

Es esencial resaltar que las minorías sexuales y de género encaran prejuicios que conllevan a una disminución en la calidad de su salud sexual, teniendo un impacto directo en su bienestar físico, mental y social, vinculado a su orientación sexual (Mereish & Poteat, 2015). Por consiguiente, enfocar la atención en visibilizar las necesidades y desafíos que enfrentan las MLB en busca de una atención médica que sea libre de discriminación, exclusión y violencia, adquiere una importancia fundamental.

Desde la perspectiva de las mujeres cisgénero lesbianas y bisexuales en Bogotá D.C., este estudio tiene como objetivo identificar sesgos de género en el sistema de atención en salud y entre los profesionales de la salud. El compromiso de visibilizar y abordar estas problemáticas es esencial para garantizar que todas las personas, independientemente de su orientación sexual, tengan acceso a una atención médica equitativa y de calidad, promoviendo así el bienestar integral de las MLB en la sociedad.

Estado del arte

La evidencia empírica de diversos estudios relacionados con barreras de acceso a la salud, han permitido, de alguna forma, visibilizar una problemática y generar conciencia sobre su impacto en la salud y bienestar de las MLB. La literatura previa de este tema aborda tres grandes dimensiones:

- 1) Literatura que habla sobre salud sexual LGBTI+ desde los discursos de los profesionales de salud y las entidades de salud.
- 2) Literatura que habla sobre salud sexual LGBTI+ desde las experiencias de las mujeres lesbianas y bisexuales.
- 3) Literatura que habla sobre el derecho al acceso a la salud.

El primer grupo, que alude la literatura que se relaciona con la salud sexual desde los discursos de los profesionales y las entidades de salud fue limitada a artículos muy puntuales, ya que el presente estudio busca enfocarse en las experiencias de las mujeres lesbianas y bisexuales. Al visibilizar las experiencias de las mujeres se busca darle voz a este grupo que históricamente ha sido silenciado. Sin embargo, al leer sobre los discursos de los profesionales, se tiene una perspectiva holística de la situación. Dentro de estos estudios que han tenido como fuente de información al personal de salud, se reconocen distintos aspectos que expongo a continuación.

El primero de ellos es sobre el conocimiento que tienen las y los profesionales en salud frente a población LGBTI. Se reconoce que se debe ampliar el conocimiento ya que este es limitado. Al respecto, Palma y Orcasita (2019) plantean que se desconocen las necesidades estructurales en el sistema de salud que están relacionadas, por ejemplo, con: la creación de historias clínicas más inclusivas que permitan el registro de las MLB. Así como la creación de guías y protocolos de atención sensibles a las necesidades de este grupo específico y, sobre todo, en la capacitación de los profesionales de la salud en temas de diversidad sexual.

Del mismo modo, destaca la imperiosa necesidad de abordar asuntos relacionados con la inclusión y la mejora de los servicios de salud, particularmente en lo que respecta a la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH, así como la realización de exámenes médicos fundamentales, tales como citologías y mamografías. Además, se hace hincapié en la importancia de prestar atención a los riesgos psicosociales derivados de la

internalización de la homofobia, subrayando la urgencia de proporcionar un enfoque integral en la atención de la salud de las MLB.

Por otro lado, Estay et al., (2020) reconocen la heteronormatividad en los sistemas de salud. Evidencian el por qué la heteronormatividad refleja una idea que se encuentra socialmente arraigada y que durante la historia ha permeado sistemas como el de la salud. La falta de conocimiento y sensibilización sobre la diversidad sexual y de género, puesto que en muchos casos los profesionales de la salud no tienen la formación necesaria para atender a personas LGBTI+ de manera integral y respetuosa. Esto conduce a prejuicios y discriminación, que pueden limitar el acceso a la atención médica y dificultar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades (Estay et al., 2020).

La falta de recursos y políticas específicas para personas LGBTI+, puede hacer que se sientan invisibilizadas o discriminadas, y puede dificultar su acceso a la atención médica. Pero ante todo la cultura heteronormativa de la sociedad, que considera la heterosexualidad como norma natural esperada y la única orientación sexual válida, puede conducir a una falta de empatía y comprensión por parte de los profesionales de la salud, y a una falta de atención a las necesidades específicas de las personas LGBTI+.

La estigmatización y discriminación para Estay et al., (2020) son factores también de igual importancia, toda vez que la sociedad a menudo estigmatiza y discrimina a las personas LGBTI+, y esta actitud puede extenderse a los profesionales de la salud. Esto se refleja en casos de comentarios inapropiados, trato insensible o discriminación abierta. Estas barreras pueden incluir la falta de reconocimiento de las necesidades específicas de salud de esta población, la falta de acceso a servicios de salud culturalmente competentes y experiencias negativas en la atención médica que disuaden a las personas LGBTI+ de buscar atención médica cuando la necesitan.

Adicionalmente, en el contexto de esta investigación, se reconocen prácticas discriminatorias en el sector salud hacia población LGBTI+. La autodenominación desempeña un papel fundamental en la identificación de la orientación sexual de las personas homosexuales y bisexuales, contribuyendo a su autodescripción, diferenciación e integración en su identidad (Vargas, 2007). La autodenominación es un concepto el cual se relaciona con la salida del closet, el cual es un proceso por el cual una persona de la comunidad declara su orientación sexual. El closet representa aislamiento y soledad (Verduzco y Gámez, 2022). De allí que el

concepto de identidad¹ cobra especial importancia, pues pese a los enfoques unidimensionales y multidimensionales, la mayoría de las aproximaciones coinciden en que la identidad engloba todas las características que una persona utiliza para definirse a sí misma.

Sin embargo, Granados (2022) revela en su investigación sobre la discriminación hacia la comunidad LGBTI+ en la atención médica que estas actitudes perjudiciales se arraigan en prejuicios profundamente enraizados, una carencia de conocimiento y sensibilidad cultural, así como actitudes discriminatorias concretas manifestadas por el personal de salud. Tales factores, sin lugar a duda, ejercen un impacto significativo en la capacidad de proporcionar diagnósticos precisos y tratamientos adecuados para esta población. El hecho de que el personal médico albergue prejuicios arraigados con respecto a la diversidad de género y orientación sexual, conduce a la formación de estereotipos y actitudes adversas hacia las personas LGBTI+. Estos prejuicios, en gran parte, derivan de la falta de información y capacitación adecuada en temas de diversidad, lo que subraya la necesidad urgente de mejorar la formación del personal médico en esta área.

Granados (2022) identifica, a su vez, que los actos discriminatorios pueden evidenciarse en gestos, actitudes corporales y comentarios verbales ofensivos, pero también, negación de servicios, retraso en la atención, consultas con poca disposición de tiempo, comunicación de mala calidad, violación en la confidencialidad, ridiculización y acoso.

El segundo grupo de literatura hace entonces referencia a la salud sexual desde las experiencias de las mujeres lesbianas y bisexuales, relacionada con testimonios de mujeres accediendo a servicios de medicina general y medicina especializada como ginecología. Entre los hallazgos que se encontraron fueron:

- a. Las mujeres lesbianas y bisexuales no acuden con la misma frecuencia que mujeres heterosexuales al ginecólogo porque implica una “salida del closet” en el consultorio que genera incomodidad y distorsión en la consulta (Brown *et al.*, 2014; Navarro *et al.*, 2016).
- b. Una vez que la paciente comunica su orientación sexual al profesional de salud, este último inicia un interrogatorio centrado en las prácticas sexuales y las infecciones de transmisión sexual, convirtiendo así la atención en un proceso de indagación (Arenas, 2018).

¹ Los seres humanos son aquellos capaces de definirse y reconocerse en distintos contextos, como lo son el físico, el académico, el profesional, el familiar, el socioeconómico, el étnico, el cultural y, el sexual (Vargas, 2007).

c. La salud sexual de las mujeres lesbianas se encuentra afectada por su orientación sexual. A propósito, Brigeiro (2009, p.93) afirma que la mala atención en servicios de salud está relacionada con la identidad sexual.

Esto, sin duda, alude los prejuicios arraigados, falta de conocimiento y sensibilidad cultural, así como actitudes discriminatorias concretas por parte del personal médico. Al respecto, Brown (2014) afirma:

“(...) tres de los principales problemas para el acceso a la salud de mujeres lesbianas y bisexuales se vinculan directamente con el carácter heteronormativo que asume la consulta: a) el ocultamiento de la orientación sexoafectiva o la gestión del secreto de la homosexualidad y, consecuentemente b) la invisibilidad de las prácticas homoeróticas femeninas, así como: c) la deficiente información disponible sumada a mitos y prejuicios difundidos” (p. 677).

El tercero grupo de literatura, relacionado con el derecho al acceso a la salud, se centra en el derecho de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, a acceder a una atención en salud de calidad y sin discriminación. En este campo, se tienen en cuenta los aportes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En específico en el artículo *Salud y derechos sexuales y reproductivos* (ACNUDH, 2018), se evidencian, por un lado, los derechos humanos que cobijan la salud sexual y reproductiva de las mujeres, como lo son: el derecho a la vida, el derecho a no ser torturada; el derecho a la salud y a la intimidad; el derecho a la educación; y, la prohibición de la discriminación.

Amparados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), se decreta entonces que los Estados se encuentran en la obligación de respetar, proteger y cumplirlos. Así también lo especificó el informe realizado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (2006). Sin embargo, la realidad evidencia lo contrario.

Al respecto y según la ONG Temblores (2021), exponer las violencias que viven estos grupos, las carencias a las que se enfrentan, las cuales se mantienen invisibilizadas y normalizadas en varios aspectos de la vida como “ciudadanes” en el Estado colombiano, resulta ser un avance en la identificación y caracterización de las experiencias que han creado barreras en la posibilidad de existir en bienestar. Por esto, dicho informe se centra en exponer las dificultades que enfrentan las personas con sexualidades y géneros disidentes en el acceso a la

atención médica, con el de generar conciencia sobre la importancia de garantizar una atención médica inclusiva y respetuosa para todas las identidades de género y orientaciones sexuales.

Finalmente, la tesis identifica que existe una brecha de conocimiento académico frente a las voces y experiencias de las MLB que atraviesan el sistema de salud de Bogotá D, C. Existen artículos que hablan sobre MLB en otras ciudades de Colombia, como Cali, por ejemplo (Palma, 2019), (Arias et al, 2011). Por otro lado, existen iniciativas del sector público, que han indagado sobre esta problemática. La Secretaría Distrital de Planeación y la Dirección de Diversidad Sexual y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, realizaron un estudio en el 2019 para identificar necesidades de lesbianas residentes en Bogotá. En él se busca entender las percepciones en salud sexual y reproductiva de mujeres lesbianas (Castiblanco, 2019). Sin embargo, es vital que este conocimiento llegue a la academia. Es por esto que la tesis identifica una brecha dentro del conocimiento académico frente a la situación de salud sexual de las MLB en Bogotá y propone un estudio cualitativo para cerrar dicha brecha.

Heteronormatividad y diversidad: tensiones y avances

El concepto de orientación sexual se ha definido de varias maneras en la literatura. La Asociación Americana de Psicología (APA, 2023) lo define como “la atracción sexual duradera de una persona hacia parejas masculinas, femeninas o ambas”. Tradicionalmente, la orientación sexual se ha clasificado en tres categorías principales: heterosexual, homosexual y bisexual. La orientación heterosexual se refiere a la atracción hacia personas del otro sexo, la homosexual se relaciona con la atracción hacia personas del mismo sexo (utilizando “gay” para los hombres y “lesbiana” para las mujeres), y la bisexualidad implica la atracción hacia personas de ambos sexos.

Sandford (1997, citado en Rueda, 2015) sostiene que la orientación sexual consta de tres componentes: atracción física o emocional, conducta sexual y autoidentidad. Los modelos que explican el desarrollo de la orientación sexual han tendido a describir linealmente la evolución de la orientación sexual homosexual. Según estos modelos, la persona primero se da cuenta de su atracción hacia personas del mismo sexo, generalmente en la niñez o adolescencia temprana, continúa con conducta sexual con personas del mismo sexo y finalmente se autodescribe como gay o lesbiana en la adolescencia tardía o en la edad adulta joven (Rueda, 2015).

En resumen, la orientación sexual se define como un patrón cognitivo, emocional, comportamental y relacional que perdura en el tiempo y que puede manifestarse en atracción hacia personas del mismo sexo, del sexo opuesto o de ambos sexos, así como hacia personas transexuales. Esta definición tiene en cuenta la complejidad de la orientación sexual y su desarrollo a lo largo de la vida de una persona.

Por su parte, la heteronormatividad se refiere a un conjunto de valores, normas, creencias y expectativas que establecen la heterosexualidad como la orientación sexual “normal” y dominante en la sociedad. Esta perspectiva asume que las relaciones sexuales y románticas “aceptables” o “legítimas” son aquellas que se producen entre personas de distinto sexo (hombre y mujer) y que el propósito principal de estas relaciones es la reproducción (Mertehikian, 2015).

La heteronormatividad también implica la invisibilización o marginalización de otras orientaciones sexuales, como la homosexualidad o la bisexualidad, considerándolas desviaciones o anormalidades en comparación con la heterosexualidad. Esta perspectiva puede dar lugar a la discriminación y al estigma hacia las personas que no se ajustan a las normas heteronormativas. En el campo de la salud, la heteronormatividad se manifiesta a través de las actitudes y respuestas de los profesionales de la salud hacia la orientación sexual diversa de las personas (Estay et al., 2020). En otras palabras, las personas que mantienen relaciones sexoafectivas que no son heteronormadas, viven lo que es la homofobia, la bifobia o la transfobia.

“Homofobia en el caso de las personas homosexuales (se sienten atraídas por personas de su mismo sexo), bifobia en el caso de las personas bisexuales (se sienten atraídas por personas de ambos sexos) y transfobia en el caso de las personas transgénero (no se identifican con el sexo que se les asignó al nacer).” (Vega, 2022).

Ipsos, líder mundial en investigación, ha realizado un estudio en 30 países, para analizar la situación actual del colectivo LGBTI+ en el mundo, en él se concluye que, a nivel global, un 9% de la población se declara LGBTI+ (Boyon, 2023). Es importante indicar que estas cifras son registros voluntarios, sin embargo, muchas veces las personas no quieren declarar su orientación sexual o identidad de género ya que esto podría tener implicaciones negativas en sus dinámicas socioculturales, políticas y económicas en sus vidas. Históricamente la comunidad LGBTI+ ha tenido discriminaciones en sus derechos humanos en el ámbito legal, social y político. Por ejemplo, existen 72 Estados que criminalizan las relaciones sexuales

consensuales entre personas adultas del mismo sexo (Carroll, 2017). En algunos países, como Brunéi, Irán, Arabia Saudí, Yemen o Uganda, puede condenarse a pena de muerte a una persona por participar en actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo (Amnistía Internacional, 2023).

La discriminación va más allá del encausamiento penal por ser LGBTI+ y puede incluir limitación del acceso a la atención sanitaria, dificultades para encontrar empleo, acoso u hostigamiento en el lugar de trabajo (Amnistía Internacional, 2023). Un ejemplo de las consecuencias de esta discriminación y prejuicios hacia la población sexualmente diversa se ve en el número de suicidios de esta comunidad, siendo mayor la incidencia que en la de la población heterosexuales; al igual que los homicidios. Según estadísticas del Centro Educativo de Salud LGBTQIA+, lesbianas, gays y bisexuales tienen un riesgo dos veces mayor de intentos de suicidio en comparación con adultos heterosexuales y en población trans es cuatro veces mayor (National LGBTQIA+ HGC, 2018). Adicionalmente, estudios del Banco Mundial, muestran como “las personas LGBT obtienen resultados educativos más bajos debido a la discriminación, la intimidación y la violencia; así mismo, registran tasas de desempleo más altas, y sufren la falta de acceso a vivienda y servicios de salud y financieros apropiados” (Kristyn Schrader-King, 2021, pág 3).

Contexto latinoamericano y colombiano

En el caso de América Latina, existe un largo camino por recorrer para reconocer los derechos de la población LGBT. El promedio de esperanza de vida de una mujer trans en la región se encuentra entre los 35.5 y los 41.2 años, mientras que la esperanza de vida cisgénero es de 75 años (ONU SIDA, 2020).

“Las relaciones homosexuales siguen estando penalizadas en nueve países de América Latina y el Caribe. Solo en cuatro países (Bolivia, Ecuador, Cuba y México) se protege de manera explícita en la Constitución a las personas LGBT, mientras que el matrimonio o la unión civil entre personas del mismo sexo se reconocen en siete. Por otra parte, hay 11 estados latinoamericanos y caribeños que reconocen las agresiones contra las personas diversas como crímenes de odio, y 14 que incluyen legislación para protegerlas de la discriminación laboral.” (Romero, 2020 pág. 1).

En Colombia, 471 mil personas se identifican como LGBTI+, esto equivale a 1,3% de la población mayor de edad (DANE, 2023). Sin embargo, no existe una garantía al derecho a la

vida ya que Colombia es el segundo país en América Latina con más asesinatos a personas LGBTI+ (El Tiempo, 2022). En 2019, fueron registrados 106 asesinatos de personas LGBTI+, en 2020 fueron 226, en 2021 fueron 208 y en 2022 fueron asesinadas 145 personas (López, 2022). Lo que significa que cada dos días y medio se cometió un homicidio contra una persona LGBTI+ en el último año (Rodríguez, 2023). En Colombia, las personas LGBTI+ siguen siendo víctimas de violaciones de derechos humanos de forma repetitiva. Estos actos son aceptados como parte de la vida cotidiana y cuentan con la complicidad de la sociedad. Como resultado, estas violaciones continúan ocurriendo sin que las autoridades y las instituciones tomen medidas efectivas para detener, prevenir o investigar estos casos (Caribe Afirmativo, 2022). Desde la sociedad civil, se están haciendo intentos por cambiar esta realidad. Colombia Diversa, una organización líder en la defensa de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans en Colombia realizó un estudio en el 2015, donde se muestra como el Estado tiene obligaciones específicas de prevención, investigación, sanción y garantía de no repetición frente a homicidios LGBTI+ en el país. La violencia hacia la comunidad LGBTI+ son crímenes a causa de prejuicios sociales ampliamente extendidos (Colombia Diversa, 2015). Adicionalmente, el Congreso de Colombia, publicó la Ley 1761 de 2015 la cual busca “sancionar penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación” (Ley 1761).

Metodología

La metodología de la tesis es de tipo cualitativa para entender las experiencias de la salud sexual de las mujeres cisgénero lesbianas y bisexuales en Bogotá. La investigación cualitativa, se enfoca a lo etnográfico por medio de entrevistas semiestructuradas en profundidad (Green, 2010). Lo etnográfico dentro del presente estudio se caracteriza por analizar las percepciones de una cultura bogotana dentro del sistema de salud a través de las voces de las MLB entrevistadas. “La cultura se revela mejor en lo que la gente hace” Wolcott (1993, 13, citado en Jociles, 2018).

Adicional a esto, la tesis opta por un conocimiento situado propio de la epistemología feminista (Haraway, 1997), un enfoque teórico-metodológico -no una técnica de análisis- donde no se desconoce el posicionamiento de la autora frente a la investigación. Nací y crecí en Bogotá y mi historia personal se usa como fuente primaria, ya que he vivido unas de las muchas barreras

que enfrentan las mujeres cisgénero bisexuales en el sistema de salud. Existe un encuentro contextual entre el sujeto investigador y el sujeto investigado el cual se conoce como enfoque biográfico (Cruz et al., 2012).

Se realizan en primera instancia una revisión de fuentes primarias y secundarias. Posteriormente, se realizan 11 entrevistas semiestructuradas, a partir de participantes seleccionadas con dos técnicas. La primera, una técnica de muestreo no probabilístico, conocida como intencional, en donde la investigadora escoge a los participantes por medio de criterios relevantes para el estudio (Otzen y Manterola, 2017). En este caso eran mujeres cisgénero lesbianas o bisexuales entre 20 y 30 años que vivieran en Bogotá por más de cinco años y usaran servicios de salud sexual y reproductiva. La segunda técnica, “bola de nieve”, en donde las MLB que se seleccionaron para las primeras entrevistas ofrecieron contactos entre sus conocidos para participar en el estudio y así progresivamente tener más acceso a la población.

Por otra parte, en este estudio cuenta con la participación de un segundo grupo de actores, quienes serán entrevistados: profesionales de la salud que tienen experiencia en la atención de mujeres lesbianas y bisexuales. A pesar de que el enfoque del estudio no se centrará en la perspectiva institucional ni en la de los profesionales de la salud, se llevaron a cabo tres entrevistas en línea con los siguientes participantes: una médica general, un ginecólogo y un funcionario de la Secretaría Distrital de Salud.

La técnica de análisis que se usó en las entrevistas en ambos grupos de actores (MLB y profesionales de la salud) fue una codificación de análisis temático unido con una indagación sociológica. Adicionalmente, al realizar un análisis de los riesgos de la investigación para las personas involucradas², además del trámite de un consentimiento informado, se determina que el estudio se hará de manera confidencial frente al nombre de las personas que participen en el estudio; el derecho a la privacidad de las participantes será una necesidad a lo largo del proyecto. Así mismo, no se relevará el nombre de los centros de salud donde se narren experiencias. Toda la información fue resguardada debidamente por la autora.

A continuación, en la Tabla 1 se evidencian los datos relevantes de cada una de las entrevistadas.

² El proyecto fue presentado al Comité de Ética del Cider y tuvo su Aval el 29 noviembre de 2022.

Tabla 1.- Perfil sociodemográfico de las participantes.

Perfil de participantes	Edad (años)	Orientación sexual	Profesión
1	29	Bisexual	Artes visuales
2	23	Lesbiana	Estudiante de ciencia política
3	27	Bisexual	Fisioterapeuta y maestría SP
4	26	Bisexual	Psicóloga y maestría PC
5	25	Bisexual	Ciencia política
6	25	Bisexual	Psicología
7	29	Bisexual	Filosofía, psicología y maestría MG
8	26	Lesbiana	Bachillerato
9	28	Lesbiana	Profesional en Psicóloga con Maestría en Estudios Culturales
10	29	Bisexual	Profesional en Economía
11	24	Bisexual	Estudiante de Gobierno y Asuntos Públicos

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de investigación.

Todas las participantes habían vivido por más cinco años en Bogotá y habían usado el sistema de salud que se tiene en la ciudad. Adicionalmente, ninguna tenía hijos y todas son mujeres latinas blancas.

A partir del marco teórico y la metodología, se definen las categorías analíticas para identificar y analizar los sesgos de género en el sistema de atención en salud sexual de MLB en Bogotá. Estas mismas categorías se identificaron para el análisis y la clasificación de las entrevistas. Como se evidencia en la Tabla 2, se generó una articulación entre el marco teórico que sitúa a las MLB y las categorías propuestas para indagar la realidad.

Tabla 2.- Articulación conceptual-metodológica

Categorías	Subcategoría
Motivo de consulta diferencial	- Infecciones vaginales - Quistes y dismenorrea - Cirugía de trompa de Falopio
Métodos de barrera e ITS	- Practicas seguras - Tamizaje de ITS
Salir del closet	- Homofobia internalizada - Heteronormatividad

Percepciones del profesional	- Capacitado e informado
Relación médico–paciente	- Calidad humana - Confianza

Resultados

Los resultados están organizados con las cinco categorías analíticas: motivo de consulta diferencial, métodos de barreras e ITS, salir del closet, percepciones del profesional, y relación médico-paciente. La tesis concluye tres premisas principales. Primero, si existen sesgos de género por orientación sexual en el sistema y los operadores de salud a partir de las experiencias de mujeres cisgénero lesbianas y bisexuales entrevistadas en Bogotá, D. C. Segundo, es crucial superar la visión heteronormativa en la atención médica, eliminar los tabúes en torno a la sexualidad y promover una comunicación confidente y abierta sobre la salud sexual en consulta. Tercero, se requiere una mayor sensibilización y formación de los profesionales de la salud en temas relacionados con la orientación sexual y la diversidad para garantizar una atención médica inclusiva y respetuosa. A continuación, se hace una clasificación por las categorías analíticas.

- **Motivo de consulta diferencial**

Pese a que los motivos de consulta pueden variar, resulta importante analizar los motivos por los cuales las mujeres accedieron a una consulta médica. En el área de salud sexual, entre las MLB entrevistadas se destacan cuatro motivos de consulta. Primero, la búsqueda de métodos de barrera y protección para la sexualidad, segundo, infecciones vaginales, tercero, quistes y dismenorrea o dolores menstruales fuertes y cuarto, cirugía de trompas de Falopio.

En esta sección se va a sustentar que las MLB resultan afectadas en su salud sexual porque el entorno de la consulta médica está diseñado en función de las necesidades de las mujeres heterosexuales. Esto significa que la mayoría de los profesionales de la salud pueden estar menos familiarizados con las necesidades de las MLB. Por ejemplo, el nivel de capacitación sobre métodos de barrera y protección para sexo entre mujeres. *“Así como en el consultorio, se tienen condones masculinos, se debería tener barreras de látex y otros métodos de protecciones para el sexo entre mujeres” (Médico general)*. Se describirá a profundidad en la cuarta categoría analítica sobre métodos de barreras e ITS este motivo de consulta de MLB.

Las mujeres lesbianas se enfrentan a una serie de desafíos en su acceso a la atención médica ginecológica, de acuerdo con las entrevistas realizadas. Estos desafíos están enraizados en estereotipos y prejuicios arraigados en la sociedad, lo que a menudo se traduce en una negación o falta de comprensión por parte de los profesionales de la salud al lesbianismo. Esto se ve demostrado en estos testimonios:

“Siendo una mujer lesbiana con una vida sexual activa desde los 16 años, nunca me han querido hacer una citología. Y siempre me han dicho, profesionales de la salud, entre comillas, siempre me han dicho que es porque como no he tenido penetración con un hombre, entonces no necesito una citología” (participante 8).

“Muchas veces he pensado como, mejor no digo que soy lesbiana, para que me den una cita ginecológica, una citología (participante 9).

Esta negación se basa en la idea equivocada de que las relaciones íntimas entre mujeres son inherentemente menos riesgosas o menos relevantes desde el punto de vista ginecológico que las relaciones con hombres. Esta perspectiva no solo es científicamente incorrecta, sino que también perpetúa la discriminación y el estigma hacia las MLB pues conlleva a la invisibilización y afirmación de la heteronormatividad en el sistema de salud.

Uno de los principales obstáculos radica en la percepción errónea de que las relaciones sexuales entre mujeres son radicalmente diferentes a las relaciones heterosexuales, lo que conduce a una falta de acompañamiento profesional adecuado y en algunos casos a la negación de procesos ginecológicos. Este acceso limitado a la citología en las MLB se evidencia por la académica Mollon (2012).

Los otros tres motivos de consulta más comunes son:

a. Infecciones vaginales

Las infecciones vaginales constituyen un motivo frecuente de consulta en atención primaria en todo el mundo. Su importancia se debe a que favorecen el contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS) bacterianas y virales y predisponen a enfermedad inflamatoria pélvica, entre otros (Villaseca et al., 2015). Las infecciones vaginales pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de las mujeres, ya que pueden ser

dolorosas, incómodas y molestas. También pueden aumentar el riesgo de complicaciones, como la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP).

Dentro del ejercicio realizado para el presente trabajo, se encontró que seis³ de las participantes, accedieron a consulta por infecciones vaginales que pudieron ser causadas por bacterias, hongos o virus, y les provocaron una variedad de síntomas, incluyendo picazón, ardor, flujo vaginal y dolor durante las relaciones sexuales.

“Yo consulte una vez por unas infecciones que hacía que tuviera relaciones sexuales dolorosas, incluso cuando iba al baño me dolía” (participante 10).

Además, se evidencia un desconocimiento de las infecciones vaginales que se pueden transmitir entre mujeres. Este se ve demostrado en el siguiente testimonio: *“como que en mi cabeza era como si las mujeres no transmitieran infecciones o lo que sea por la educación en sexualidad es tan heteronormativa como que uno mismo dice no pues a mí no me dijeron esto es porque no pasa” (participante 5).* Esto puede retrasar el tratamiento y aumentar el riesgo de complicaciones.

b. Quistes y dismenorrea

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es una disfunción ovárica que afecta a las mujeres en edad reproductiva; de acuerdo con Dres Kee J. et al. (2006), las mujeres con SOP suelen tener factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, como: obesidad, hipertensión arterial, hiperinsulinemia e hiperandrogenismo. A menudo, estas pacientes presentan un aumento de síntomas que se convierten con el paso del tiempo en problemáticas serias que, de acuerdo con las participantes son subestimadas.

“yo sufro de quistes en los ovarios y de periodos dolorosos desde el colegio, para el manejo me mandaron a planificar con pastillas, siento que normalizamos mucho como los periodos dolorosos, pero eso no es normal, no es normal que tú no te puedas levantar de la cama por los cólicos (participante 2).

Las participantes: 2, 4, 5, 9 y 11 coincidieron en que desafortunadamente, el cólico menstrual a menudo se subestima y no recibe el tratamiento necesario. Esto se debe a que

³ Participantes 2, 3, 5, 6, 7 y 10.

el dolor menstrual se considera un "dolor femenino" y, por lo tanto, se asume que es algo normal. Sin embargo, el dolor menstrual severo o dismenorrea no es normal. Puede ser un signo de un problema subyacente, como la endometriosis, la adenomiosis o la enfermedad pélvica inflamatoria, entre otras que suelen invisibilizadas.

c. Cirugía de trompas de Falopio

La participante 1 y 3 coincidieron en que, al momento de entablar una conversación relacionada con la posible cirugía de trompas de Falopio, los médicos (hombres) se anticipan a una reflexión no solicitada con respecto a la corta edad y orientación sexual. E incluso, aseveran que no se puede realizar tal procedimiento hasta que la persona no tenga hijos. Cuestionando incluso la autonomía a la hora de decidir no maternar.

“como que en el proceso de obtener como la cirugía, digamos que juzgaban mucho mi decisión por mi edad y mi bisexualidad, sí me parece feo que puedan intimidar, porque pues ahí ejercen un poco el poder que tienen y una persona se puede sentir mal” (participante 3)

Sin duda, en un contexto de reconocimiento legal de los derechos sexuales y reproductivos, el acceso limitado a la ligadura de trompas de Falopio constituye una de las barreras en cuanto al alcance efectivo de derechos que hacen, particularmente, las mujeres.

El derecho a decidir tener hijos o no y cuándo tenerlos a través de la adopción se encuentra limitado en Colombia, y se relaciona con un grave desconocimiento de la Ley 1412 del 19 de octubre de 2010. Esta ley “ordena que los médicos encargados de realizar el procedimiento, previamente a la cirugía, deben informar al paciente la naturaleza, implicaciones, beneficios y efectos sobre la salud de la práctica realizada, así como las alternativas de utilización de otros métodos anticonceptivos no quirúrgicos”, (Bogotá, octubre 22 de 2010.- Boletín de prensa No.285). La ley no le brinda la potestad en negar el servicio cuando la decisión está tomada de forma autónoma; cabe destacar que se trata de una decisión que se encuentra en el ámbito de la esfera personal de la mujer.

2. Métodos de barrera e ITS

La desinformación en relación con los métodos de barrera es un problema significativo que persiste en Bogotá y que es reconocido en las entrevistas realizadas. Esta falta de conocimiento puede llevar a una percepción errónea de que las relaciones sexuales solo se validan si involucran penetración, lo cual es un estigma perjudicial que afecta especialmente a las personas que tienen relaciones no heteronormativas.

“eso también me molesta porque todo va dirigido a la penetración, todo está enfocado a que las relaciones sexuales son entre un pene y una vagina, y dejan por fuera el resto de las prácticas” (participante 10)

A partir de las entrevistas, se encuentra que la búsqueda de información sobre métodos de barrera suele depender de la iniciativa personal y la investigación independiente en lugar de la orientación por parte de profesionales de la salud. Es esencial destacar que la falta de información sobre la prevención de ETS entre las MLB es un problema significativo. Se percibe, que a menudo, se ven obligadas a buscar y adquirir conocimientos por su cuenta, sin recibir orientación adecuada de profesionales de la salud.

En muchos casos, los médicos pueden proporcionar información básica y superficial sobre estos métodos, lo que deja a las MLB sin la comprensión adecuada de cómo protegerse de manera efectiva en sus relaciones sexuales. Esto se debe a que los profesionales de la salud pueden no estar familiarizados con las necesidades de las MLB en materia de prevención de ITS. Como resultado, las MLB tienen menos probabilidades de utilizar métodos de barrera, durante las relaciones sexuales.

“Me parece muy fuerte, pero muy fuerte que no hablamos de esto, pero escuchar que xxx dice que solo con sus amigas, y luego yo dije que solamente con las amigas hemos hablado de sexo y el taller de las feministas, me parece una gonorrea, o sea, me parece una gonorrea que de verdad esos sean los únicos espacios donde nosotras podamos hablar libremente de sexo, de sexualidad, de prácticas sexuales (participante 9).

Esta falta de orientación sobre métodos de barrera, como los condones femeninos, y sobre las pruebas de sangre para detectar ITS, deja a las MLB en desventaja en términos de cuidado de la salud sexual. A veces, las charlas sobre protección y prevención se limitan a eventos o iniciativas específicas, en lugar de ser una parte integral de la atención médica proporcionada por las EPS (Entidades Promotoras de Salud), lo que resalta la importancia de expandir y fortalecer la educación sobre salud sexual y la disponibilidad de recursos informativos accesibles para todas las personas, sin importar su orientación sexual.

“Siento que las disidencias sexuales han tenido que encontrar sus propias formas de cuidado. Uno aprende también a ver en quién confía, en quién no, qué tipo de canales de información. Pero usualmente yo acudo a activistas homosexuales o trans, u organizaciones de estos mismos grupos que saquen información”
(participante 7).

Incluso, muchas afirman que es imperativo que los profesionales de la salud se esfuercen por ofrecer una educación integral sobre la salud sexual, que incluya la prevención de ETS y la diversidad de prácticas sexuales, para garantizar que todas las personas tengan acceso a información precisa y relevante; ya que la desinformación y la falta de orientación en este sentido pueden tener graves repercusiones para la salud sexual y el bienestar de las MLB.

El riesgo latente asociado con la falta de información y acceso a métodos de barrera es una preocupación constante para las entrevistadas. A menudo, las barreras de látex u otros métodos de prevención de ETS pueden ser difíciles de encontrar o adquirir. Además, la falta de conocimiento sobre dónde obtener estos recursos y la ausencia de discusiones abiertas sobre métodos de barrera contribuyen a la percepción errónea de que la sexualidad se reduce exclusivamente a la anticoncepción.

Esta visión limitada deja de lado la importancia de reconocer y abrazar la sexualidad como un aspecto fundamental de la identidad personal y la intimidad compartida en las relaciones. Además, cuando se solicitan exámenes de control, algunas MLB enfrentan la desconfianza y el cuestionamiento por parte del personal médico, lo que dificulta aún más el acceso a una atención médica integral y respetuosa.

“Creo que su reacción me llevó a un momento de desesperación en donde yo le dije como, es que soy una persona promiscua y quiero hacerme exámenes, porque sé que para muchos médicos tener relaciones sexuales sin que sea con una única pareja, pues es una conducta de riesgo, entonces quiero hacerme eso”
(participante 5).

Adicionalmente, se observa un enfoque excesivo en la anticoncepción en lugar de en la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS). En ocasiones, los profesionales de la salud no recomiendan métodos de barrera para protegerse de ETS en relaciones sexuales entre mujeres. Esta omisión es especialmente preocupante dado que las ETS pueden transmitirse a través del contacto íntimo sin penetración.

“Creo que sigue estando mayoritariamente relacionado el servicio sexual y reproductivo a la anticoncepción, específicamente a mujeres que usan anticonceptivos, como recargando a las mujeres con esa responsabilidad”
(participante 7).

Sin embargo, es importante destacar que algunas personas participantes también han experimentado una apertura en la discusión de temas que antes eran tabú, como el uso de copas menstruales y la gestión menstrual. En los últimos años, ha habido un aumento en la visibilidad y disponibilidad de opciones de salud sexual y reproductiva, como el condón femenino, que anteriormente eran menos conocidas y difíciles de encontrar en algunos lugares. Estos avances indican un progreso positivo en la promoción de una conversación más abierta y educativa sobre la salud sexual y reproductiva, lo que puede beneficiar a todas las personas, independientemente de su identidad de género u orientación sexual.

Es esencial reconocer que, a partir de las entrevistas se coincide con que muchos de los servicios de salud sexual tienden a enfocarse principalmente en las mujeres cisgénero y su anticoncepción, dejando de lado discursos que promuevan el placer en la sexualidad y la importancia de mantener prácticas sexuales seguras. Esta falta de atención al placer y al bienestar sexual puede contribuir a la percepción de que la salud sexual se limita a la prevención de embarazos y no incluye aspectos fundamentales de la intimidad y la satisfacción sexual. Además, el enfoque es selectivo en la realización de pruebas rápidas de VIH solo en ciertos contextos, como en consumidores de drogas o personas que han tenido relaciones homosexuales, puede reforzar estereotipos y discriminación, dejando

fuera a aquellos que podrían beneficiarse de una evaluación de salud más amplia y equitativa.

Es importante señalar que el miedo infundado en torno a la realización del primer chequeo de VIH es una experiencia común, influenciada en gran medida por estigmas y prejuicios culturales en torno a la infección por VIH. Este temor a menudo es alimentado por una percepción negativa y estigmatizada de la enfermedad, lo que resalta la necesidad de una educación más amplia y precisa sobre el VIH y la importancia de los chequeos regulares para una detección temprana y el cuidado de la salud.

“Hace 6 años, me hice mi primer examen de VIH y no lo mandaban por correo, sino que uno tenía que ir al centro de salud donde fue por el examen. Recuerdo que te lo entregaba o la enfermera jefa o la psicóloga y yo pensaba: tengo sida. Osea, como, ¿por qué más iban a entregarme este examen así? Y cuando fui, era negativo y fue como cuál es la necesidad de este show” (participante 7).

Algunas mujeres se enfrentan a juicios y críticas por parte del personal médico en relación con sus elecciones de salud reproductiva. La presión para consumir anticonceptivos hormonales u otras opciones puede generar un ambiente de confrontación en lugar de apoyo y respeto por la autonomía del cuerpo. El estigma relacionado con la promiscuidad también es un obstáculo significativo en la búsqueda de atención médica y refuerza la necesidad de una atención médica más inclusiva y libre de prejuicios que empodere a todas las personas para tomar decisiones informadas sobre su salud y bienestar.

Es cierto que, en muchas ocasiones, las MLB se enfrentan a la sorpresa de los profesionales de la salud cuando plantean preguntas específicas o solicitan exámenes adicionales. Esto puede deberse a la falta de educación y sensibilización en el ámbito médico en relación con las necesidades y preocupaciones de las MLB. Además, existe una percepción errónea de que las mujeres son tímidas o reticentes a hacer preguntas sobre su salud sexual, lo que a menudo conduce a un acceso limitado a información y recursos necesarios.

La percepción negativa en torno a que una mujer solicite condones y los lleve consigo es otro ejemplo de los estereotipos de género arraigados en la atención médica. Esta actitud refleja la necesidad de un cambio cultural en la forma en que se abordan y se ofrecen los

recursos de salud sexual. Además, es preocupante que las EPS limiten la cobertura de exámenes a VIH, sífilis y hepatitis, excluyendo pruebas importantes como la de gonorrea. Lo anterior se ve reflejado en el testimonio:

“De hecho, recuerdo la cara cuando le dije que no tenía relaciones con hombres. Y fue como, ah, no, entonces, nada es necesario. Como ya, siguiente tema, ni siquiera me examinó, no me reviso la vulva, impactante (participante 9).

Sin duda, la falta de acceso y recursos adecuados para el cuidado de la salud sexual entre MLB es un desafío preocupante. Como menciona la participante 11, *“es difícil encontrar preservativos diseñados específicamente para relaciones sexuales entre mujeres en farmacias o establecimientos de salud”*. Este problema subraya la importancia de abordar la brecha en la disponibilidad de recursos para el cuidado de la salud sexual y la necesidad de educación inclusiva para profesionales de la salud.

También afirma que es esencial que los profesionales de la salud se cuestionen y se preparen para brindar una atención integral y sin prejuicios. La falta de conocimiento y formación en temas relacionados con la salud sexual LGBTI+ es evidente en muchas situaciones, lo que lleva a respuestas inadecuadas o insuficientes por parte del personal médico. Se necesita una revisión del sistema de salud y una mayor inversión en la formación de profesionales para garantizar que estén equipados para abordar las necesidades de todas las personas, sin importar su identidad de género u orientación sexual.

Además, es fundamental reconocer que la educación y los recursos disponibles a menudo están sesgados hacia una perspectiva cisgénero y heteronormativa, dejando de lado las experiencias y necesidades de personas transgénero y no cisgénero. Para lograr una atención verdaderamente inclusiva y accesible, es esencial que se amplíen y se simplifiquen los recursos disponibles y se eliminen los obstáculos que dificultan el acceso a la atención de salud sexual. En última instancia, se debe trabajar para eliminar el desinterés de los profesionales de la salud por las relaciones sexuales entre mujeres y garantizar que todas las personas tengan acceso a una atención médica respetuosa, informada y equitativa.

3. Salir del clóset

La “salida del closet” es cuando una MLB u otra persona de la comunidad LGBTI+ declara su orientación sexual diversa a sus distintos círculos sociales. La heteronormatividad en la sociedad hace que las MLB no puedan expresar con facilidad su orientación sexual. Cuando una persona no expresa su sexualidad diversa, se dice que la persona “está en el closet”, encerrada (Verduzco y Gámez, 2022, 79).

“Uno no sabe cómo abordarlo, porque cree que puede incomodar a la persona, o se puede volver un momento incómodo” (participante 1). Estas dudas surgen debido a la preocupación de incomodar a las personas o de que el tema se vuelva incómodo. La homofobia social y la internalización de prejuicios pueden contribuir a esta ansiedad. La falta de empatía y comprensión por parte de quienes rodean a la MLB puede exacerbar aún más esta inseguridad.

Incluso en el contexto de la atención médica, surgen inquietudes. Algunas MLB han experimentado juicios y cuestionamientos de los profesionales médicos cuando revelan su orientación sexual. Esto puede generar una sensación de incomodidad y llevar a una comunicación cerrada en la consulta. Así se evidencia *“ok yo soy lesbiana y soy lesbiana para mis amigas y familia, pero qué pereza tener que decirle a una persona completamente desconocida que soy lesbiana, es incómodo, no sé, luego que te salen con esas cosas de mal gusto y cero profesionales (participante 2).*

La reacción de *shock* o la pérdida de amabilidad por parte del personal médico es una experiencia lamentablemente común. En ocasiones, en especial con médicos mayores, las MLB optan por no mencionar su orientación sexual debido al sesgo personal y a la asunción de una orientación sexual heteronormativa. Esto se evidencia en los siguientes testimonios:

“uno de los mayores retos para mi es el de afrontar miradas, opiniones que nadie pide, afrontar una sociedad que no te hace sentir segura (...) era mi ginecólogo de toda la vida, le dije que ahora tenía relaciones con otras mujeres y él se puso completamente rojo, eso me incomodo bastante” (participante 6).

“Creo que también ese tipo de cosas pueden seguir afectando la salud mental, sobre todo, siendo una niña o siendo una joven, sin experiencia, más insegura de todo, pero es donde uno debe confiar en el profesional, porque se supone que esa persona estudia, entonces debería darte herramientas, sobre todo, a una edad más temprana” (participante 8).

“El clóset es una figura que representa tanto el aislamiento y la represión auto/inducida, como un espacio de seguridad que sirve como contención y que permite atender a demandas heteronormadas sin el riesgo de vulnerarse” (Verduzco y Gámez, 2022, 79). La necesidad de afrontar una sociedad que a menudo no brinda un ambiente seguro es palpable en las entrevistas realizadas. Las MLB deben encontrar formas de lidiar con estas situaciones emocionalmente desafiantes. Algunas recurren a omitir información sobre su orientación sexual en entornos médicos o de otro tipo debido al temor al juicio. El estigma internalizado de la cultura en la que crecieron también influye en su disposición a compartir abiertamente su identidad.

“Pues muchas veces he pensado como, mejor no digo que soy lesbiana, para que me den una cita ginecológica, una citología, como que se me cuestione eso, he pensado como en mentir, nunca he mentido, pero sí pasa que, pues el consultorio es como un lugar como muy íntimo, y da miedo el consultorio” (participante 8).

En el contexto médico, existe una preocupación adicional relacionada con la percepción de que solo las relaciones sexuales con penetración son relevantes para la atención ginecológica, lo que invalida las experiencias de las mujeres lesbianas y bisexuales. Esto puede llevar a la duda sobre si mencionar la orientación sexual es necesario para recibir atención médica adecuada.

“Yo iba muy precavida, y cuando me preguntaron por qué quería el examen, entonces dije que había terminado con una pareja, que habían pasado los tres meses, pero no fui capaz de decirle que era una persona trans, porque sabía que venía como ese juicio. Yo ya tenía tan en mi cabeza que esto era algo mal visto por los médicos, que entonces solo omití esa información” (participante 7).

En muchas ocasiones, se plantean cuestionamientos y juicios desafortunados en torno a la planificación familiar y la sexualidad de las personas MLB. Se ha observado que, en

algunos casos, cuando una persona revela que está en una relación homosexual, la conversación sobre planificación familiar se cierra abruptamente. Este cierre prematuro de la discusión puede privar a las personas LGBTI+ de la oportunidad de recibir información y orientación sobre opciones de planificación familiar que son igualmente relevantes para ellas, como para cualquier otra persona. Estos malentendidos y prejuicios subrayan la necesidad de una mayor educación y sensibilización en el ámbito de la salud, así como la importancia de proporcionar información precisa y compasiva a todas las personas, independientemente de su orientación sexual. “Como si ser lesbiana pues fuera como que no, que nunca me va a pasar nada, ser lesbiana no me quita la cuca” (participante 8).

4. Percepciones del profesional

Una de las formas más notables de estigmatización entre las MLB está relacionada con la búsqueda de atención médica, en particular, en el ámbito de la ginecología. De hecho, varias entrevistadas sienten que serán juzgadas por su orientación sexual o por sus prácticas sexuales por parte del personal médico. Este temor puede llevar a evitar consultas médicas importantes, lo que, a su vez, puede tener graves repercusiones para su salud.

La estigmatización en la atención médica no se limita solo a la orientación sexual, sino que, a partir de esta, se extiende a la percepción de riesgo de enfermedades de transmisión sexual (ETS). Algunas mujeres participantes temen que los profesionales de la salud asuman que no están en riesgo de ETS debido a su orientación sexual, lo que podría llevar a diagnósticos tardíos o falta de pruebas preventivas. Esto pone de manifiesto la necesidad de una atención médica basada en la evidencia científica y libre de prejuicios.

“Como que uno no quiere incomodar, y no quiere tener ese momento tenso”
(participante 1).

“De hecho, recuerdo la cara cuando le dije que no tenía relaciones con hombres. Y fue como, ah, no, entonces, nada es necesario. Como ya, siguiente tema, ni siquiera me examinó, no me reviso la vulva, impactante (participante 9).

Otro temor significativo que enfrentan algunas MLB es el miedo a la humillación o al juicio por parte del personal médico. La percepción de que sus prácticas sexuales sean

objeto de escrutinio o burla puede llevar a la ocultación de información relevante durante las consultas médicas, lo que nuevamente perjudica su atención y bienestar. Esto se puede ver reflejado en:

“uno se siente como predispuesto a, ¿será que le pregunto? ¿será que le tengo que dar explicaciones de por qué estoy preguntando?” (participante 1).

“una vez sí les pedí como una consulta con ginecología, mantener relaciones con mujeres es muy diferente a tener relaciones con hombres, entonces yo quería como una asesoría y básicamente eso sí me lo negaron. Me dijeron que no, porque yo estaba teniendo infecciones recurrentes, porque las prácticas con mujeres en muchas ocasiones pues no hay tanta lubricación, y uno utiliza pues como los dedos, juguetes, otro tipo de cosas. Eso me generaba más infecciones que con los hombres, porque con los hombres hay pues un poco más de lubricación por parte y parte. Y esa vez sí me lo negaron porque no sé si la persona no sabía, no entendía, yo le decía no, es que yo sí necesito conocer cómo voy a tener prácticas seguras sin que de pronto yo me lastime, cosas así. Pero no, no supieron darme respuesta y me negaron la cita, dijeron no, eso no es de ginecología” (participante 3)

Además de estos temores, se suma una experiencia profundamente perturbadora relacionada con la falta de consentimiento durante la exploración ginecológica. Algunas mujeres entrevistadas han informado haber sufrido invasiones de su privacidad en el consultorio médico, donde el personal médico no ha respetado su consentimiento durante la revisión de la zona genital. Esta violación de la intimidad no solo es inaceptable, sino también traumática, generando sentimientos de ansiedad, estrés y desconfianza en el sistema de atención médica. Lo anterior se ve reflejado en el testimonio de la participante 2: *“Ella entró a un practicante que al igual que la ginecóloga, te miran como hasta la cerviz porque te abren de piernas, es muy incómodo que no te pidan tu consentimiento para esas cosas”.*

Es importante destacar que, existe una diferencia entre la percepción que tienen las mujeres entrevistadas sobre el personal de salud cuando se trata de una consulta de relaciones heterosexuales y homosexuales. El siguiente testimonio lo refleja:

“Siempre lo he comparado como con las otras consultas que yo tenía cuando yo tenía relaciones con hombres. Y son muy diferentes, porque evidentemente ya cuando tú dices que es una relación con un hombre, sí te preguntan cómo tienes varias parejas, solo una pareja, con qué te proteges y como que ahí sí indagan bastante en toda la prevención. Pero pues básicamente con, desde que he tenido relaciones con mujeres, siempre ha sido como esa barrera de, ok, mejor vamos a continuar y no tocar este tema” (participante 3)

Finalmente, durante las consultas médicas, las mujeres lesbianas pueden enfrentar reacciones por parte del personal médico que, en lugar de brindar apoyo, hieren profundamente sus sentimientos. *“yo salí de esa consulta como, como estresada, como nerviosa, como inquieta” (Participante 2)*. La sorpresa o la falta de comprensión por parte de algunos profesionales médicos pueden ser evidentes en sus expresiones faciales o en comentarios inapropiados. Estas reacciones pueden hacer que las pacientes se sientan incomprendidas, avergonzadas o marginadas, lo que puede generar una brecha significativa en la relación de confianza entre el paciente y el médico. *“Súper incómodo hablar de sexualidad, es decir, me parece [la consulta médica] los lugares menos seguros para hablar de sexualidad” (participante 9)*.

5. Relación médico-paciente

La relación médico paciente es un aspecto relacionado con la calidad de la atención médica y en Bogotá es un tema de preocupación constante que se hace evidente a lo largo de las entrevistas y el desarrollo del presente trabajo.

La visión heteronormativa de la sociedad limita la comprensión y la empatía hacia las realidades de las personas con orientaciones sexuales diversas y, en general, hacia la diversidad sexual, afectando de manera directa la relación médico-paciente.

En muchas ocasiones, se ha observado que existe una falta de conocimiento y sensibilidad por parte de los profesionales de la salud en relación con las enfermedades de transmisión sexual y los métodos de protección adecuados para las MLB. Esta falta de información y comprensión contribuye a la perpetuación de estereotipos y prejuicios que pueden dificultar el acceso a la atención médica de calidad.

El impacto de esta visión heteronormativa se hace evidente en la forma en que las mujeres se sienten al interactuar con el sistema de salud. Cuando sienten que sus identidades y experiencias no son reconocidas o validadas, es natural que se sientan menos inclinadas a hacer preguntas importantes sobre su salud sexual o a responder preguntas de los profesionales de la salud. Lo anterior se puede evidenciar en el testimonio de la participante 8: *“A mí siempre me ha ido mal, porque siempre me siento súper invalidada.”*

La honestidad en torno a la orientación sexual y la diversidad sexual es crucial en la relación médico-paciente. Sin embargo, la persistencia de la visión heteronormativa puede crear una barrera significativa para que las MLB compartan esta información de manera abierta y confiada. Esto tiene un impacto directo en la calidad de la atención médica que reciben, ya que la orientación sexual y la identidad de género pueden ser factores determinantes en el diagnóstico y tratamiento de ciertas condiciones de salud.

Además de superar la visión heteronormativa en la atención médica, es esencial desterrar los tabúes en torno a la sexualidad y promover una comunicación abierta sobre el cuidado sexual en consulta. Es comprensible que, para muchas personas, especialmente las MLB, hablar sobre sexualidad en un entorno médico pueda resultar incómodo y desafiante. Para superar este obstáculo, se deben implementar estrategias que promuevan la confianza y la apertura en la comunicación entre los pacientes y los profesionales de la salud. Esto incluye discutir temas relacionados con la higiene y el uso de juguetes sexuales, así como proporcionar educación sexual integral. Como profesionales de la salud, es deber informar y actualizar sobre estos temas para brindar un apoyo completo a los pacientes. Para cambiar esta percepción, es fundamental destacar la importancia de los exámenes ginecológicos regulares, no solo en el contexto de la reproducción y la anticoncepción, sino también en relación con el bienestar general y el placer sexual. *“Al igual que se recomienda una visita anual al odontólogo para una limpieza dental, se debería promover un chequeo ginecológico anual como una práctica estándar de cuidado preventivo”* (participante 2).

Uno de los retos más comunes que se perciben en las entrevistas, en relación esta área es la invisibilización de la orientación sexual, el estigma y la hipersexualización en la consulta médica. Por lo que afirman que es fundamental que los profesionales de la salud reconozcan la diversidad de las experiencias sexuales y se esfuercen por brindar un

ambiente libre de juicios y prejuicios. Esto podría incluir la disponibilidad de materiales informativos, como panfletos, que los pacientes puedan llevarse consigo para obtener más información y comprender mejor su salud sexual, como un aspecto natural y saludable de la vida humana que merece ser respetado y disfrutado sin prejuicios ni estigmas.

“Los médicos sienten que tienen ese, ese, ese saber oculto que no te pueden decir y ellos mandan, entonces ellos pueden tomarte muestras y sacarte exámenes de cuanta cosa y no te dicen. Te reciben sin mirarte a los ojos, entonces siempre están viendo el computador. Luego, si son de una EPS, pues más rápido todavía. Entonces, en 20 minutos tienen que sacarte toda la información. Creo que eso hace que, de por sí, ya una cita médica sea muy estresante. Una cita en ginecología es aún más estresante cuando la persona que te va a revisar ni siquiera se nota genuinamente interesada”, (participante 9).

Las MLB entrevistadas, en particular, a menudo se sienten desinformadas y desconfiadas debido a la falta de atención y cobertura adecuadas para la diversidad sexual en comparación con las relaciones heterosexuales. Esta desconfianza hacia el sistema y los profesionales de la salud es comprensible, ya que temen ser juzgadas o malentendidas. La atención en los servicios de salud ha sido permeada por el sistema patriarcal y machista, así como por los estereotipos de género, lo que ha llevado a una falta de comprensión y apoyo hacia las necesidades específicas de las mujeres lesbianas y bisexuales. Lo anterior se ve reflejado en el siguiente testimonio:

“Creo que yo confío más en la información de las disidencias. Hay una cosa de la que yo estoy segura y es que unas de las personas que mejor saben cuidarse en términos de salud sexual y reproductiva o como en exposición a enfermedades de transmisión sexual, son las disidencias sexuales”, (participante 7).

La crítica generalizada, de parte de las entrevistadas, hacia el sistema de salud colombiano refleja las profundas inequidades y diferencias presentes en la sociedad. Estas disparidades se hacen evidentes en la atención médica, donde la orientación sexual y el estrato socioeconómico de una persona pueden influir significativamente en su experiencia. Desafortunadamente, estas diferencias persisten en gran medida en el sistema de salud colombiano, donde *“ser una mujer lesbiana de estrato 6 es diferente de una mujer lesbiana de estrato 1” (participante 8).*

Finalmente, se destaca la urgencia de una continuar con la lucha para que el acceso a la salud no sea un privilegio, sino un derecho fundamental. El Estado y el Gobierno colombiano deben llegar a todos los rincones del país, especialmente a aquellos lugares que han sido históricamente marginados y desatendidos. Entendiendo que la salud sexual es un aspecto fundamental de la vida de todas las personas, y su acceso no debe ser limitado por la ubicación geográfica o el estrato socioeconómico. Todos, sin importar su situación, tienen derecho a una atención médica de calidad que aborde sus necesidades de salud sexual y bienestar en general.

Conclusiones

Con base a los resultados y hallazgos presentados en este estudio sobre la experiencia de las MLB en la consulta médica, se pueden extraer las siguientes conclusiones. Los motivos de consulta de las MLB en salud sexual son la búsqueda de métodos de barrera para la sexualidad, infecciones vaginales, quistes, dolores menstruales y cirugía de trompas de Falopio. Es importante destacar que, en la experiencia de atención médica de las mujeres entrevistadas, a menudo se observa una notable falta de información y discusión sobre la planificación de la salud sexual y métodos de prevención. Mientras que, en las relaciones heterosexuales, los ginecólogos y el personal médico suelen brindar amplia información sobre métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades de transmisión sexual, esta misma atención preventiva parece pasar desapercibida en el caso de las mujeres lesbianas. Esta omisión no solo refleja una falta de comprensión de las prácticas sexuales y las necesidades de salud específicas de las mujeres lesbianas, sino que también puede poner en riesgo su bienestar. Esto se puede ver en el siguiente testimonio de una participante bisexual, quien narra su experiencia cuando acudió al iniciar su vida sexual con hombres y después con mujeres.

“Al hablar de relaciones sexuales hetero y homo, si te perciben diferente en el sistema de salud, han sido dos primeras veces para mí. Cuando fui a hablar de relaciones con hombres, era fácil, orgánico (...) La respuesta fue muy diferente, sentí el cambio cuando hable de relaciones con mujeres, la primera respuesta: “no sé cómo vas a hacer para cuidarte, no tengo ni idea, no sé cómo hacerlo (...) La médica estaba tan desinformada como yo, viví un baldado de agua fría, porque ya había tenido una respuesta heteronormativa, y esta fue opuesta. Si hay una

diferencia entre una persona que tiene relaciones con un hombre y con una mujer” (participante 11).

Esta desinformación sobre métodos de barrera y salud sexual en general es un problema persistente, y muchas MLB dependen de la iniciativa personal y la investigación independiente en lugar de recibir orientación adecuada de los profesionales de la salud. Se destaca la necesidad de una educación integral en salud sexual que incluya la prevención de ETS y la diversidad de prácticas sexuales.

Además de las barreras mencionadas, es crucial resaltar que muchas mujeres lesbianas también enfrentan un dilema en cuanto a la honestidad en sus consultas médicas en relación con su vida sexual y la percepción de promiscuidad. La falta de un enfoque médico adecuado y de dirección en cuanto a exámenes médicos específicos para las MLB puede llevar a la renuencia o a discutir abiertamente sus experiencias sexuales en el consultorio médico. Esto se debe a la preocupación de ser estigmatizadas, juzgadas o malinterpretadas, lo que podría resultar en una falta de evaluación adecuada de su salud sexual y la ausencia de recomendaciones pertinentes de exámenes médicos preventivos.

Unido a lo anterior, una de las principales dificultades que enfrentan las mujeres lesbianas en la consulta médica es la necesidad de salir del clóset. Este proceso puede ser molesto e incómodo, ya que las MLB pueden sentirse presionadas a revelar su orientación sexual antes de que estén listas. Además, el entorno de la consulta médica puede ser percibido como hostil o inseguro para las mujeres lesbianas, lo que puede dificultar aún más la revelación de su orientación sexual. La homofobia internalizada puede ser un desafío para las mujeres lesbianas. Algunas mujeres lesbianas pueden tener sentimientos de vergüenza o culpa por su orientación sexual. Esto puede dificultar la comunicación con los profesionales de la salud sobre su orientación sexual.

Es fundamental que los profesionales de la salud se esfuercen por crear un entorno de atención médica seguro y acogedor para todas las pacientes, independientemente de su orientación sexual. Para ello es esencial abordar las reacciones inapropiadas por parte del personal médico, como la sorpresa o la falta de comprensión, que pueden herir los sentimientos de las pacientes y socavar la relación de confianza. La capacitación en sensibilidad y diversidad sexual debe ser una parte integral de la formación médica para garantizar una atención médica respetuosa y libre de prejuicios.

La atención médica, en particular en el contexto de la salud sexual, a menudo se enfoca en la anticoncepción en lugar de en la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS), lo que resulta en una falta de información sobre métodos de barrera y la importancia de la prevención de ETS en relaciones sexuales no heteronormativas. Esto lleva a que algunas MLB oculten su orientación sexual por temor al juicio y la falta de comprensión por parte de los profesionales médicos.

En conclusión, si existen sesgos de género por orientación sexual en el sistema y los operadores de salud a partir de las experiencias de mujeres cisgénero lesbianas y bisexuales entrevistadas. Es crucial superar la visión heteronormativa en la atención médica, eliminar los tabúes en torno a la sexualidad y promover una comunicación abierta sobre la salud sexual en consulta. Además, se necesita una mayor sensibilización y formación de los profesionales de la salud en temas relacionados con la diversidad sexual para garantizar una atención médica inclusiva y respetuosa.

Finalmente, a partir de lo encontrado en esta tesis es esencial llevar a cabo futuras investigaciones que evalúen la formación y la sensibilización de los profesionales de la salud en temas relacionados con la diversidad sexual. Estas investigaciones pueden identificar las brechas en la formación universitaria y proponer recomendaciones para mejorar la capacitación de los médicos y otros proveedores de atención médica. Así mismo, sería prudente llevar a cabo estudios que evalúen las políticas de salud sexual existentes en la Secretaría de Salud en relación con su inclusión de la diversidad sexual y su impacto en el acceso y la calidad de la atención médica para las personas LGBTQ+. Esto podría llevar a recomendaciones para mejorar las políticas de salud sexual y abordar la visión heteronormativa.

Por último, es importante señalar algunas limitaciones encontradas en el análisis de este estudio. En primer lugar, se debe mencionar que la muestra de participantes en las entrevistas fue relativamente pequeña y no necesariamente representativa de la diversa población de Bogotá D.C. Esto implica que los resultados pueden no ser generalizables a toda la población de interés. Para futuras investigaciones, se recomienda ampliar la muestra, adoptando una muestra heterogénea que permita la comparación de datos entre distintas categorías, como raza, identidad de género, estatus migratorio, edad y nivel socioeconómico.

Referencias

- Arias, L., Vásquez, M. L., Dueñas, E. P., García, L. M., & Tejada, E. L. (2011). Comportamiento sexual y erotismo en estudiantes universitarios, Cali, Colombia. *Colombia médica*, 42(3), 309-318.
- ACNUDH. (2018). Salud y derechos sexuales y reproductivos. El ACNUDH y los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Ginebra: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
- ACNUDH. (2006). Promoción y protección de los derechos humanos: cuestiones relativas a los derechos humanos, incluidos distintos criterios para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Resolución 61/166. Nueva York: Naciones Unidas.
- Amnistía Internacional (2023, 26 julio). DERECHOS LGBTI. Amnistía Internacional. <https://www.amnesty.org/es/what-we-do/discrimination/lgbti-rights/>
- Arenas, S. H. (s). Experiencias de atención en salud de personas LGBT y significados del personal de salud que les atiende. [Tesis de maestría, Universidad El Bosque]. <http://hdl.handle.net/20.500.12495/1967>.
- American Psychological Association. (2023, febrero 1). Orientación sexual e identidad de género. Recuperado de <https://www.apa.org/topics/lgbtq/sexual>.
- Barrera, E. L. S. (2017). El movimiento LGBT (I) en Colombia: la voz de la diversidad de género. Logros, retos y desafíos. *Reflexión política*, 19(38), 116-131.
- Boyon Nicolas (2023, junio 1). Pride month 2023: 9% of adults identify as LGBT+. Ipsos. <https://www.ipsos.com/en/pride-month-2023-9-of-adults-identify-as-lgbt>
- Brown, J. L., Pecheny, M., Tamburrino, M. C., Conde, L. L., Perrotta, G. V., Capriati, A., Andia, A. M., Mario, S., & Ibarlucia, I. (2014). Atención ginecológica de lesbianas y bisexuales: notas sobre el estado de situación en Argentina. *Interface - Comunicação, Saúde, Educação*, 18(51), 673–684. <https://doi.org/10.1590/1807-57622013.0049>.
- Brigeiro, M., Castillo, E., & Murad, R. (2009). Encuesta LGBT: Sexualidad y Derechos participantes de la marcha de la ciudadanía LGBT de Bogotá, 2007. Universidad Nacional de Colombia / Profamilia / Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM) /IMS-UERJ. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/52753>.
- Carmona-Meza, Z., & Parra-Padilla, D. (2015). Determinantes sociales de la salud: un análisis desde el contexto colombiano. *Revista Salud Uninorte*, 31(3), 608-620. <https://doi.org/10.14482/sun.31.3.7685>.
- Carroll, A., y Mendos, L. R. (2017) Homofobia de Estado 2017: Estudio jurídico mundial sobre la orientación sexual en el derecho: criminalización, protección y reconocimiento Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) https://ilga.org/sites/default/files/ILGA_Homofobia_de_Estado_2017_WEB_0.pdf

- Caribe Afirmativo (2022). No se mata lo que no se olvida: Informe sobre la situación de los derechos humanos de personas LGBTIQ+ en Colombia 2022. <https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2023/03/INFORME-DDHH-LGBTIQ2023-CA.pdf>
- Castiblanco C. (2019, 22 de octubre). Alcaldía de Bogotá. <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/planeacion/derechos-sexuales-y-reproductivos-de-mujeres-lesbianas-en-bogota>
- Chaparro, R. (2015). Efecto del entrenamiento para intervención psicológica con población de gays, lesbianas y bisexuales. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Colombia Diversa (2015). Personas LGBT asesinadas en 2015. Recuperado de: <https://colombiadiversa.org/ddhh-lgbt/>
- Cruz, M. A., Reyes, M. J., & Cornejo, M. (2012). Conocimiento Situado y el Problema de la Subjetividad del Investigador/a. *Cinta de Moebio*, (45), 253-274. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2012000300005>.
- Departamento Administrativo Nacional De Estadística - DANE. (2023, julio 11). Mercado laboral de la población LGBT. DANE. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-la-poblacion-lgbt#:~:text=Durante%20el%20a%C3%B1o%20m%C3%B3vil%20junio,de%20edad%20en%20el%20pa%C3%ADs>.
- El Tiempo (2022, agosto 26). Ser LGBTQ+ en Colombia es una sentencia de muerte. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/por-que-ser-gay-lesbiana-transexual-o-queer-es-una-sentencia-de-muerte-en-colombia-533692>
- Estay, F., Valenzuela, A., & Cartes, R. (2020). Atención en salud de personas LGBT+: Perspectivas desde la comunidad local penquista. *Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología*, 85(4), 351-357. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262020000400351>.
- Formby, E. (2011). Lesbian and bisexual women's human rights, sexual rights and sexual citizenship: negotiating sexual health in England. *Cult Health Sex*, 13(10), 1165-1179. <https://doi.org/10.1080/13691058.2011.610902>.
- Granados-Cosme, J. A. (2022). La investigación sobre discriminación a LGBT en la atención médica. *DIVULGARE Boletín Científico De La Escuela Superior De Actopan*, 9(17), 10-16. <https://doi.org/10.29057/esa.v9i17.8075>.
- Green, J., & Thorogood, N. (2010). *Qualitative methods for health research* (2nd ed.). London: Sage.
- Guerrero, R., Gallego, A. I., Becerril-Montekio, V., & Vásquez, J. (2011). Sistema de salud de Colombia. *Salud Pública de México*, 53(2), 144-155. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342011000800010&lng=es&tlng=es.
- Haraway, D. (1997). [Modest Witness@Second Millennium.FemaleMan Meets_OncoMouse: Feminism and Technoscience](#). New York-London: Routledge.

- Hiestand, K. R., Horne, S. G., & Levitt, H. M. (2007). Effects of gender identity on experiences of healthcare for sexual minority women. *Journal of LGBT health research*, 3(4), 15–27. <https://doi.org/10.1080/15574090802263405>.
- Hilarión-Gaitán, L., Díaz-Jiménez, D., Cotes-Cantillo, K., & Castañeda-Orjuela, C. (2019). Desigualdades en salud según régimen de afiliación y eventos notificados al Sistema de Vigilancia (Sivigila) en Colombia, 2015. *Biomédica*, 39(4), 737–747.
- Jociles Rubio, M. I. (2018). La observación participante en el estudio etnográfico de las prácticas sociales. *Revista colombiana de antropología*, 54(1), 121-150.
- Kristyn Schrader-King, (2021) Orientación sexual e identidad de género. Recuperado de <https://www.bancomundial.org/es/topic/sexual-orientation-and-gender-identity>
- Ley 1752 de 2015: C Actos de Racismo o discriminación. Congreso de la Republica. (junio 3 de 2015). D.O. No. 49531.
- López Alejandra (2022, junio 27). Población LGBT en Colombia: más educada y con mayor desempleo. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/vida/tendencias/cuantas-personas-lgbt-hay-en-colombia-esto-dice-el-dane-683046>
- Mereish, E. H., & Poteat, V. P. (2015). A relational model of sexual minority mental and physical health: The negative effects of shame on relationships, loneliness, and health. *Journal of counseling psychology*, 62(3), 425.
- Mertehikian, Y. A. (2015). Salud sexual-reproductiva y heteronormatividad: experiencias con los servicios de salud de jóvenes lesbianas y bisexuales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2022, 6 octubre). Discapacidad y enfoque diferencial. Gobierno Colombiano. <https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Discapacidad/Paginas/enfoque-diferencial.aspx>.
- Mollon, L. (2012). The forgotten minorities: health disparities of the lesbian, gay, bisexual, and transgendered communities. *Journal of Health Care for the Poor and Underserved*, 23(1), 1-6. <https://doi.org/10.1353/hpu.2012.0009>.
- Naciones Unidas (2023, 5 octubre). La Agenda para el Desarrollo Sostenible. UN <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/>
- National LGBTQIA+ Health Education Center (2018, 2 octubre). Suicide Risk and Prevention for LGBTQ Patients. Enway Institute. <https://www.lgbtqiahealtheducation.org/publication/suicide-risk-and-prevention-for-lgbtq-patients/>
- Navarro-Corona, C. I., Rocha Sánchez, T. E., Tena Guerrero, O., Cruz del Castillo, C., Herrera, C. M., & Castañeda Salgado, P. (2016). Mujeres diversas: experiencias de opresión y resistencia en el ámbito de la salud sexual. *Psicología Iberoamericana*, 24(2), 44-52.

- Organización Mundial de la Salud. (2010). *Developing Sexual Health Programmes: A Framework for Action*. Ginebra. Recuperado de .
- Ortiz-Ruiz, N., Díaz-Grajales, C., López-Paz, Y., Zamudio-Espinosa, D. C., & Espinosa-Mosquera, L. (2023). Necesidades en salud sexual y reproductiva en migrantes de origen venezolano en el municipio de Cali (Colombia). *Revista Panamericana de Salud Pública*, 47, e4.
- Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. *International Journal of Morphology*, 35(1), 227-232. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037>.
- Palma, D. M., & Orcasita, L. T. (2019). Discursos de profesionales de la salud sobre la salud sexual de mujeres lesbianas y bisexuales. *Interface - Comunicação, Saúde, Educação*, 23, e170329. <https://doi.org/10.1590/Interface.170329>
- Rodríguez Carol (2023, abril 11). Durante 2022 en Colombia, cada 2 días se asesinó a una persona LGBTIQ. RCN Radio. <https://www.rcnradio.com/colombia/durante-2022-en-colombia-cada-2-dias-se-asesino-a-una-persona-lgbtqi>
- Romero Mar. (2020, 29 julio). La diversidad LGBT+ en América Latina: un largo camino por recorrer. Recuperado de <https://www.france24.com/es/20200628-diversidad-lgbt-america-latina-retos>
- Rueda Sáenz, M. (2015). El significado del prejuicio sexual en las trayectorias de la identidad con la orientación sexual homosexual y bisexual. *Uniandes*.
- Ruiz-Sternberg, Á. M., Beltrán-Rodríguez, J., Latorre-Santos, C., & Ruiz-Sternberg, J. E. (2010). ¿ Existe asociación entre los comportamientos de riesgo en salud sexual y reproductiva y el ser estudiante de medicina?: Estudio de corte transversal. Bogotá (Colombia). *Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología*, 61(2), 121-128.
- Sobecki-Rausch, J. N., Brown, O., & Gaupp, C. L. (2017, September). Sexual dysfunction in lesbian women: A systematic review of the literature. In *Seminars in reproductive medicine* (Vol. 35, No. 05, pp. 448-459). Thieme Medical Publishers.
- Temblores ONG. (2021). *Sin curas ni remedios: Diagnóstico sobre las barreras de acceso a la salud para personas con sexualidades y géneros disidentes en Colombia*. Bogotá, Colombia: Temblores ONG.
- Teresi, J. A. (2006). Different approaches to differential item functioning in health applications: Advantages, disadvantages and some neglected topics. *Medical care*, S152-S170.
- Vargas Trujillo, E. (2013). *Sexualidad... mucho más que sexo: una guía para mantener una sexualidad saludable*. Universidad de los Andes.
- Vega Alonso del Val. (2022). "10 preguntas sobre la homofobia, transfobia y bifobia." *Amnistía Internacional*. <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/10-preguntas-sobre-la-homofobia-transfobia-y-bifobia/>.
- Verduzco, I. L., y Gámez, N. P. (2022). Salir del clóset desde la perspectiva sistémica: Un estudio de caso. *Revista Puertorriqueña de Psicología*, 34(1), 76-90.

Villaseca, R., Ovalle, A., Amaya, F., Labra, B., Escalona, N., Lizana, P., Montoya, M. J., Lillo, E., & Martínez, M. A. (2015). Infecciones vaginales en un Centro de Salud Familiar de la Región Metropolitana, Chile. *Revista Chilena de Infectología*, 32(1).

World Health Organization. (2010). *Developing sexual health programmes: A framework for action* (No. WHO/RHR/HRP/10.22). World Health Organization.